

Task 5: Оцінка слуху (Тести Рінне і Вебера)(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Саражина Катерина Святославівна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Оцінити вміння діагностики слуху
Обладнання:

- 1. Камертон С-128
- 2. Камертон С-2048

Витратні матеріали:
Не потрібно
Брифінг

Ви — лікар-невропатолог. До вас звернувся 54-річний чоловік зі скаргами на погіршення слуху на ліве вухо протягом останніх кількох місяців. Він заперечує біль або виділення з вуха, але каже, що чує гірше саме з одного боку.

ok

Текст завдання

Ви — лікар-невропатолог. До вас звернувся 54-річний чоловік зі скаргами на погіршення слуху на ліве вухо протягом останніх кількох місяців. Він заперечує біль або виділення з вуха, але каже, що чує гірше саме з одного боку.
Завдання:

- 1. Проведіть тест Вебера та поясніть його значення.
- 2. Проведіть тест Рінне та поясніть його значення.
- 3. Визначте можливий тип порушення слуху.
- 4. Які додаткові обстеження можуть знадобитись?

ok

Чеклист

1. -Привітатися з пацієнтом, представитися, запитати як може звертатися до пацієнта Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Запитати що турбує пацієнта, уточнити скарги Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. - Уточнити чи є супутні симптоми (біль, шум у вухах чи виділення з вуха) Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. - Пояснити пацієнту необхідність та техніку проведення діагностичних тестів Рінне і Вебера Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Обрати необхідний камертон Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

6. - Зараз я проведу тест Вебера, поставити камертон на середину чола пацієнта. Скажіть, у якому вусі звук гучніший. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Запитати чи є різниця звуку у вухах. Скажіть, у якому вусі звук гучніший. Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Сказати що тепер проведемо тест Рінне. Притиснути камертон до кістки за вухом – "скажіть, коли звук вібрації зникне". Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Сказати: тепер я піднесу камертон до вуха – скажіть, чи чуєте звук. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Пояснити результати тестів пацієнту Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
11. -поставити попередній діагноз Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
12. -Скерувати пацієнта на необхідне дообстеження Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

Студент (лікар)	Актор (пацієнт)
Добрий день! Мене звати [ім'я], я лікар-невропатолог. Як я можу до вас звертатися?	Доброго дня, мене звати Олександр.
Що вас турбує?	Я помітив, що останнім часом погано чую лівим вухом.
Чи є у вас біль, шум у вухах чи виділення?	Ні, просто чую гірше, особливо коли розмовляють з лівого боку.
Я проведу два тести, щоб оцінити ваш слух. Спочатку – тест Вебера. Я поставлю камертон на середину вашого чола. Скажіть, у якому вусі звук гучніший.	(Чує звук краще в правому вусі) У правому.
Це означає або провідникову приглухуватість у лівому вусі, або сенсоневральну приглухуватість у правому. Тепер проведемо тест Рінне. Я притисну камертон до кістки за вухом – скажіть, коли звук зникне. Потім я піднесу його до вуха – скажіть, чи знову чуєте звук.	(На лівому вусі: звук зникає на кістці, але не чується у повітрі) Я чую тільки, коли камертон на кістці, але біля вуха – ні.
Це негативний тест Рінне для лівого вуха, що свідчить про провідникову приглухуватість.	Тобто проблема саме в лівому вусі?
Так. Для встановлення точного діагнозу потрібне аудіометричне дослідження та консультація ЛОРа.	Дякую, лікарю!

Студент (лікар)	Актор (пацієнт)
Добрий день! Мене звати [ім'я], я лікар-невропатолог. Як я можу до вас звертатися?	Доброго дня, мене звати Олександр.
Що вас турбує?	Я помітив, що останнім часом погано чую лівим вухом.
Чи є у вас біль, шум у вухах чи виділення?	Ні, просто чую гірше, особливо коли розмовляють з лівого боку.
Я проведу два тести, щоб оцінити ваш слух. Спочатку – тест Вебера. Я поставлю камертон на середину вашого чола. Скажіть, у якому вусі звук гучніший.	(Чує звук краще в правому вусі) У правому.
Це означає або провідникову приглухуватість у лівому вусі, або сенсоневральну приглухуватість у правому. Тепер проведемо тест Рінне. Я притисну камертон до кістки за вухом – скажіть, коли звук зникне. Потім я піднесу його до вуха – скажіть, чи знову чуєте звук.	(На лівому вусі: звук зникає на кістці, але не чується у повітрі) Я чую тільки, коли камертон на кістці, але біля вуха – ні.
Це негативний тест Рінне для лівого вуха, що свідчить про провідникову приглухуватість.	Тобто проблема саме в лівому вусі?
Так. Для встановлення точного діагнозу потрібне аудіометричне дослідження та консультація ЛОРа.	Дякую, лікарю!